

14 - 06- Les tumeurs urothéliales - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui concerne les tumeurs de la vessie et des voies excrétrices. Il s'agit de l'ensemble des tumeurs bénignes et malignes, primitives ou secondaires, développées au dépôt des voies urinaires. Principalement la vessie, mais aussi les calices, bassinées, urtères et uretères.

Dans ces tumeurs, il existe une notion de maladie de l'urotélium. Cette notion de maladie de l'urotélium ou maladie de la muqueuse urotéliale vient du fait que dans 8 à 10% des cas, les tumeurs sont de localisations multiples ou multifocales sur l'ensemble de l'arbre urinaire. Nous consacrerons la majeure partie de ce cours à étudier les tumeurs de la vessie parce qu'elle constitue la grande majorité des tumeurs développées au niveau des voies urinaires.

Elle représente le deuxième cancer urologique après celui de la prostate, principalement les tumeurs épithéliales. Les tumeurs de vessie présentent un large spectre de lésions, depuis des tumeurs simplement récidivantes localement, jusqu'aux tumeurs agressives et métastatiques. Voici le plan que nous allons suivre dans notre cours aujourd'hui.

En guise de rappel anatomique, les voies urinaires s'étendent d'urin avec les calices, le bassinet, les deux urtères, puis la vessie et l'urètre. Ces voies urinaires sont toutes tapissées par un épithélium dit transitionnel ou urotélium. C'est la base de développement des tumeurs urotéliales.

La paroi, en plus de la muqueuse, comprend un plan musculaire très développé, le muscle détrusor au niveau de la vessie. Et en périphérie, on retrouve un adventis qui est couvert d'une séreuse seulement à la partie supérieure de la vessie. Concernant la classification des tumeurs de la vessie et des voies excatrices, elles sont dominées par les tumeurs épithéliales, principalement de type urotélial.

Les tumeurs non-épithéliales, beaucoup moins fréquentes, peuvent être de type mésenchymateuse ou autre. Attention à ne pas confondre une tumeur primitive avec une métastase d'un cancer à distance ou surtout l'extension d'une tumeur de voisinage. En images, la classification des tumeurs urotéliales.

Quelques notions importantes avant de commencer la description de nos tumeurs de vessie. Nous parlerons des tumeurs urotéliales de la vessie. Elles peuvent être scindées en deux.

Tumeurs papillaires, c'est-à-dire qui développent des papilles en surface. Et des tumeurs non-papillaires, qui ne développent pas de papilles. Les tumeurs papillaires sont les plus fréquentes.

Elles sont scindées en deux. Non-invasives ou infiltrant le chorion et dites donc invasives. Dans les tumeurs papillaires non-invasives.

Elles peuvent être scindées en papillomes. Tumeurs papillaires de faible potentiel de malignité.

Le carcinome papillaire de bas grade.

Le carcinome papillaire de haut grade. Les tumeurs papillaires infiltrant le chorion ou dites invasives. On aura alors ce qu'on appelle le carcinome urotélial infiltrant.

Qui peut être de bas grade ou de haut grade. Pour les tumeurs non-papillaires. On a deux stades.

Celui de carcinome insidu. Comme dans toutes les autres tumeurs. Et le stade suivant.

C'est celui de carcinome urotélial infiltrant. De bas grade. Ou de haut grade.

Toujours dans les notions importantes. Avant d'entamer la description anatomopathologique des tumeurs de la vessie. Et nous parlons des lésions urotéliales non-invasives.

C'est à dire n'infiltrant pas le chorion. Elles sont scindées en deux. Selon qu'elles soient d'origine papillaire.

Ou non-papillaire. Pour les non-papillaires. Elles ne diffèrent pas des autres tumeurs des autres localisations.

La prolifération urotéliale à potentiel de malignité incertain. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie. La dysplasie.

Et le carcinome insidu. Intéressons nous maintenant aux lésions papillaires. Qui sont particulières des tumeurs urotéliales.

On a d'abord le papillome. Avec une variante dite papillome inversé. La néoplasie urotéliale papillaire de faible potentiel de malignité.

Et le carcinome urotélial. Papillaire de bas grade. Et de haut grade.

Notez le terme de carcinome urotélial. Même si c'est non-invasif. Une particularité des tumeurs urotéliales.

Entendons la description des tumeurs de vessie. En prenant comme type de description les tumeurs urotéliales vésicales. En général, les tumeurs de vessie viennent au niveau du deuxième rang des tumeurs urogénitales.

Une prédominance masculine. Et un âge moyen de 65 ans. 90% des tumeurs de vessie sont des tumeurs urotéliales.

Avec un spectre allant d'une prolifération récidivante localement. A des tumeurs agressives, voire qui vont métastaser. Concernant les tumeurs urotéliales vésicales.

70% sont des tumeurs superficielles. On verra ce que c'est ultérieurement. 25% sont des

tumeurs infiltrant le muscle, le détruisor.

On verra l'importance de ce critère. Et 5% sont des tumeurs métastatiques. Concernant les facteurs de risque.

On retrouve le tabac et l'exposition professionnelle. Notamment aux amines aromatiques et aux hydrocarbures. Ce qui concerne les industries du textile, du cuir, de la peinture, la pétrochimie.

Et l'imprimerie. D'autres facteurs de risque. Notamment certaines thérapeutiques.

Un traitement aux cyclophosphamides au long cours. Un antécédent de radiothérapie pelvienne. Certaines infections vésicales chroniques comme la bilharziose.

Et enfin, les tumeurs urotéliales sont plus fréquentes dans la race blanche, le sexe masculin et les personnes âgées. D'autres anomalies peuvent être incriminées dans le développement de tumeurs vésicales. Ces anomalies vont générer des irritations vésicales chroniques.

Que ce soit l'extrophie vésicale. Un antécédent de cathétérisme chronique. Des calculs chroniques.

Et la vessie neurologique. Du fait du cathétérisme régulier. Quel est le rôle du pathologiste à bord de poser le diagnostic positif de la tumeur ? Aussi établir les facteurs histopronostiques, le type histologique, le grade et le stade.

Enfin, le suivi du malade sous traitement. Les malades atteints de tumeurs urotéliales vésicales sont généralement contrôlés régulièrement par des biopsies. Que le pathologiste va à chaque fois étudier pour suivre le malade.

Concernant le matériel d'étude dans les tumeurs urotéliales de vessie. On peut avoir d'abord la cytologie urinaire. Qui a un intérêt surtout dans le dépistage.

Et surtout dans le carcinome in situ. Cette cytologie urinaire peut être aussi intéressante dans la surveillance d'une tumeur qui a déjà été opérée. Deuxième matériel d'étude.

Ce sont les biopsies sous cystoscopie. Au niveau des lésions planes, non papillaires. Ou sur la muqueuse apparemment saine autour d'une tumeur réséquée.

Ce qui permettra de faire une cartographie des lésions. La cystoscopie permet un examen macroscopique des lésions. Avec notamment le siège, le nombre et l'aspect.

Et va guider donc le nombre de biopsies. Troisième matériel d'étude. Ce sont les copeaux de résection endoscopique trans-urétrale de la tumeur.

Pour des tumeurs papillaires. Ces copeaux vont permettre d'établir un diagnostic de cancer de vessie. A l'examen anatomopathologique qui va étudier ces copeaux.

On va avoir un aspect des lésions. Est-ce que c'est des papilles qui sont fines. Ou plutôt fusionnées, voire carrément des nodules.

Élément capital dans les copeaux de résection. Un flacon doit être à part qui contient la musculieuse. L'endoscopiste doit faire une biopsie profonde au-dessous de la papille.

Au pied de la lésion. Pour ramener la musculieuse qui va être étudiée à l'anatomopathologie. Pour essayer de voir si elle est infiltrée ou pas.

Au laboratoire d'anatomopathologie, les différents copeaux seront pesés. Et surtout, ils seront inclus en totalité. Pour l'examen anatomopathologique.

Quatrième matériel d'étude, c'est la pièce opératoire. Ça peut être une cystoprostatectomie. Une cystectomie.

Voire une pelvictomie antérieure, si il y a une tumeur étendue. Enfin, c'est des tumeurs qui sont plutôt sur les léurètres. Les calices ou le bassinnet.

On peut aller jusqu'à une néphro-urétérectomie. Pour les tumeurs de la voie excatrice haute. Aspect de tumeur papillaire au niveau de la vessie.

À l'état frais et fixé. Cet aspect papillaire bourgeonnant. Enchouffleur pour des tumeurs très évoluées.

Au laboratoire d'anatomopathologie. Une pièce opératoire pour tumeur urétériale de vessie. On va comporter les éléments suivants.

Le siège de la tumeur. Son diamètre. Sa distance par rapport au col vésical.

L'aspect macroscopique. Est-ce qu'il est papillaire, bourgeonnant, ulcéré, ulcéro-bourgeonnant, infiltrant? Est-ce qu'il est unique ou plurifocal? Est-ce qu'on note des zones indurées au niveau de la graisse périvésicale? Suspectant une extension au-delà de la vessie. Atteinte de la prostate qui va être ancrée.

Et vérification des limites d'exérès chirurgical. Concernant l'aspect anatomoclinique des tumeurs urétériales. On peut décrire trois modes.

Les tumeurs d'aspect macroscopique papillaire. Dites superficielles. Jusqu'à 70% des cas.

Elles peuvent être uniques ou multiples. Elles ont tendance à récidiver. Et à progresser d'un stade moins agressif à un stade plus agressif avec la récurrence.

Deuxièmement, le carcinome in situ isolé. Moins de 5% des cas. Le diagnostic n'est pas toujours évident en cystoscopie.

Enfin, le carcinome urétérial infiltrant. Il peut être d'emblée diagnostiqué à ce stade dans 30% des cas. Ou plus souvent succédé à des lésions soit papillaire superficielle qui ont évolué et progressé.

Soit un carcinome in situ. Les différents aspects anatomoclinique des tumeurs urétrales. Papillaire non invasif.

Carcinome papillaire invasif. Carcinome in situ. Qui ne concerne que l'épithélium.

Carcinome urétérial infiltrant d'emblée. Entendons la description microscopique des tumeurs urétrales. Qui vont être syndéons néoplasiques urétrales qui sont non invasives.

D'origine papillaire ou plane, non papillaire. Principalement le carcinome in situ. Et le carcinome urétérial infiltrant.

Rappel sur les tumeurs urétrales de la vessie. Syndéons non papillaires. Avec deux stades in situ et infiltrant.

Et papillaires qui sont syndés en deux. Non invasives. Avec le papillum.

Les tumeurs papillaires de faible potentiel de malignité. Le carcinome papillaire de bas grade et de haut grade. Et les tumeurs papillaires infiltrant le chorion.

Le carcinome urétérial infiltrant de bas grade ou de haut grade. Nous parlerons d'abord des tumeurs urétrales. 90% c'est notre type de description.

Dans ces tumeurs urétrales, on a d'abord les néoplasies urétrales non invasives. Papillaire ou non papillaire. Dans le papillaire, on a le papillum urétérial.

La néoplasie urétrale de faible potentiel de malignité. Le carcinome urétérial de bas grade de malignité. Le carcinome urétérial de haut grade de malignité.

Et nous avons le carcinome urétérial infiltrant. Concernant le grade des tumeurs urétrales. Il représente le degré de différenciation de la tumeur.

Il est basé sur l'étude de l'architecture et l'aspect cytologique des cellules tumorales. Nous allons étudier d'abord les néoplasies urétrales non invasives de type papillaire. Ce tableau résume les principaux signes microscopiques au niveau des 4 lésions rencontrées dans la néoplasie urétrale non invasive papillaire.

D'abord une petite remarque. Encore une fois, on parle de carcinome papillaire de bas grade et de haut grade. Même si c'est non invasif.

C'est une particularité des tumeurs urétrales. En général, le papillome, l'aspect de l'épithélium est tout à fait normal. Sauf que c'est une formation papillaire.

La néoplasie papillaire de faible potentiel de malignité. Très peu d'anomalies. Juste une épaisseur un peu augmentée et quelques anomalies légères.

Les anomalies sont un peu plus importantes dans le carcinome papillaire de bas grade. Et la désorganisation est nette dans le carcinome papillaire de haut grade. Sauf qu'il n'y a pas d'invasion.

Le papillome. C'est une tumeur rare. Moins de 1%.

Elle touche le sujet jeune. C'est une tumeur de petite taille unique. Pédiculée avec des franges qui sont grêles.

Sur le plan microscopique. Ces papilles sont recouvertes par un épithélium d'aspect normal. L'évolution est exceptionnellement vers la récurrence.

Le papillome inversé. C'est une tumeur rare. Moins de 1%.

Des tumeurs eurotéliales. En général solitaires. Une forme un peu polypoïde.

Moins de 3 cm. Sa surface externe est lisse. Ce n'est pas une tumeur qui se développe dans la lumière viscale.

Elle va se développer de manière endophytique à l'intérieur de la paroi. Donc on aura une surface lisse, non bourgeonnant ou très peu. Sur le plan histologique.

On va avoir des travées qui vont être anastomosées entre elles. A développement interne endophytique. Et élément important.

Il n'y a pas d'infiltration du coriole. Ce n'est pas une tumeur invasive. La néoplasie papillaire de feu potentiel de magnités.

C'est une lésion papillaire qui est exophytique. C'est-à-dire qu'elle va se développer vers la cavité viscale. Elle a un taux de récurrence qui est faible.

De 20 à 30%. C'est-à-dire que 20 à 30% des tumeurs. Néoplasie papillaire de feu potentiel de magnités.

Vont récidiver après résection. Et un très faible taux de progression. Moins de 5%.

C'est-à-dire une tumeur. Néoplasie papillaire de feu potentiel de magnités. Qui a été réséquée.

Si elle récidive. Dans moins de 5% des cas seulement. Elle va récidiver vers un type plus agressif.

Exemple. Carcinome papillaire de bas grade. Ou de haut grade.

En tout cas, elle est rarement infiltrante. Elle a survécu à 10 ans. De 95 à 98% des cas.

L'aspect histologique. De la néoplasie papillaire. De peu potentiel de malignité.

Papilles fines. L'épaisseur qui est variable. La polarité nucléaire est en général conservée.

Les cellules sont. Monomorphes. Discrètement augmentées de taille.

Quelques atypies. Les noyaux un petit peu allongés. Mais la chromatine reste fine.

Pas de nucléole. Peu de mitose. Et la maturation en surface est normale.

Le carcinome papillaire. Non infiltrant de bas grade. Non infiltrant.

Même si on parle de carcinome encore une fois. C'est une particularité des tumeurs urotéliennes. C'est une tumeur.

Exophytique. Elle a un taux de récurrence plus élevé. 60% des tumeurs.

Carcinome papillaire non infiltrant de bas grade. Vont récidiver. Et donc 15% elles vont récidiver.

Vers un type plus agressif. Exemple. De haut grade.

La prise en charge va dépendre. De sa taille. Du caractère unique ou multiple.

Et surtout. S'il y a eu des récurrences. A plusieurs reprises.

L'aspect du carcinome papillaire de bas grade. Avec des papilles qui sont fines. L'épaisseur elle est variable.

Avec une discrète perte de la polarité. Les atypies sont un peu plus importantes. La taille des cellules est plus augmentée.

Les atypies. Avec notamment les formes des noyaux. Plus accentuées.

Allongées. Ovale. Rondes.

Pas de nucléoles. Ou très peu visibles. Les mitoses.

Sont un peu plus nombreuses. Que dans la néoplasie papillaire. Mais en général.

La maturation peut être conservée. Ou pas. Donc plus ou moins.

Conservation de la maturation en surface. Le carcinome papillaire non infiltrant de haut grade. C'est une tumeur papillaire exophytique.

Ou endophytique. Donc elle peut se développer. Dans la lumière.

Physicale. Ou profondément dans la paroi. Elle est souvent associée à des lésions.

Planes de type carcinome in situ. Elles présentent un taux de récurrence élevé. 60 à 85% des tumeurs.

Ayant un carcinome papillaire de haut grade non infiltrant. Qui sont résectionnées. Elles vont récidiver.

Et elles vont progresser vers une tumeur. Plus agressive. Donc infiltrante.

Dans 20 à 35% des cas. L'aspect du carcinome papillaire de haut grade. C'est les papilles qui sont plus fines.

Elles sont épaisses. Et fusionnées entre elles. Donc bourgeonnantes.

Très grossières. On a une désorganisation architecturale. Qui est claire, manifeste.

Cellules qui sont augmentées de taille. Un important pléomorphisme au niveau de la forme des noyaux. On a des nucléoles qui sont bien visibles.

On a des mitoses qui sont fréquentes. Et absence de maturation. Donc c'est une tumeur qui a l'aspect d'une tumeur maligne.

Juste qu'elle est encore non infiltrante. Dans ce cas. Aspect histologique dans le carcinome urotérial non infiltrant de haut grade.

Notez l'important pléomorphisme. Les atypies. L'aspect franchement agressif.

Seulement, il n'y a pas d'infiltration à ce stade. Après avoir étudié les tumeurs urotérial papillaires. Nous allons passer aux tumeurs urotérial non papillaires.

Avec un développement plus classique. Carcinome in situ. Carcinome infiltrant.

Le carcinome in situ. Sur le plan macroscopique. C'est une lésion qui est plane.

Non papillaire. Qui va se caractériser par. Une muqueuse rougeâtre.

Qui est d'aspect finement granité. Elle peut être multifocale. Elle peut même toucher.

Et s'étendre au delà de la vessie. Au niveau de l'urètre. Et les urètres.

Sur le plan microscopique. Le carcinome in situ. Au niveau de la vessie.

Ne change pas d'un autre carcinome in situ. Dans d'autres organes. On va avoir une désorganisation.

Architecturale qui est majeure. Avec des atypicitons nucléaires marqués. Et surtout.

Pas d'infiltration. Au niveau du courant. On peut avoir.

Des formes cliniques. Le carcinome in situ isolé primitif. Ou associé.

A un carcinome urotéglal. Le carcinome in situ. Peut être confondu.

Avec d'autres lésions planes. D'hyperplasie. De dysplasie.

Ou avec des atypies. D'ordre régénératif. Pour faire la part des choses.

Au niveau de ces quatre lésions. Quelques éléments. Peuvent aider au diagnostic.

Le nombre de couches cellulaires. Est variable dans les atypies. Supérieur à 7 dans l'hyperplasie.

Variable dans la dysplasie. Et le carcinome in situ. La polarisation.

Ou la conservation de la polarisation. Cellulaire. Elle peut être variable dans les atypies.

Elle est normale dans l'hyperplasie. Elle est désorganisée. Dans la dysplasie.

Et le carcinome in situ. Le rapport nucléocytoplasmique. Peut être normal.

Ou faiblement augmenté. Dans les atypies réactionnelles. Et l'hyperplasie.

Il est faiblement augmenté. Dans la dysplasie. Il est très augmenté dans le carcinome.

In situ. Un élément peut être. Pour le carcinome in situ.

Qui le fait un petit peu. Se différencier des autres carcinomes in situ. Des autres organes.

L'atteinte de la totalité de l'épithélium. N'est pas obligatoire. Nous passons maintenant au carcinome.

Urotélial infiltrant. Infiltrant. Le coriandre.

Ou plus profondément. Le muscle détruisant. Aspect macroscopique et microscopique.

De ces tumeurs infiltrant. Qui peuvent être juste au niveau du coriandre. Et là au niveau du muscle.

Voici le muscle détruisant. Et les boyaux. Carcinomateux.

Qui infiltrent ce muscle. En termes de carcinome urotélial infiltrant. Deux rôles.

Importants pour le pathologiste. D'abord authentifier l'infiltration. Qu'elle soit.

De cellules dispersées. Comme ici. Sous forme d'amas.

Ou infiltration vasculaire. Le deuxième rôle. Du pathologiste.

Est la précision du niveau d'infiltration. De ce carcinome. Est-il limité seulement au coriandre.

On parle de PT1. Est-il étendu. Au détruisant PT2.

Ce qui est encore plus important à préciser. Les implications thérapeutiques. De ces précisions.

Et la suivante. Lorsqu'on a. Une infiltration du muscle. Le détruisant.

La cystectomie est indiquée. Lorsqu'on a. Une atteinte seule du coriandre. Pas d'atteinte du muscle.

La résection biopsique. De la tumeur. Est suffisante.

Aspect histologique. Une infiltration du muscle détruisant. De la vessie.

Le muscle. Ici et ici. Qui est infiltré.

Massivement. Par une prolifération tumorale. Cet aspect correspond.

A un stade PT2. Les facteurs histopronostiques. Pour une tumeur urotéliale.

De vessie. C'est d'abord le type histologique. Le grade.

Ce dernier représente un facteur pronostique. De survie pour les tumeurs. Qui permet aussi d'évaluer le risque de progression.

Et de récurrence. Pour les tumeurs superficielles. Troisièmement le stade.

TNM. La présence d'embolie vasculaire. Le mode de croissance.

Papillaire. Ou sur le mode plan. Et la taille tumorale.

Classification TNM des tumeurs vésicales. Importante. A connaître.

Avec le stade PTA. Lorsqu'on a une tumeur papillaire. Qui est non infiltrante.

A ce moment là. L'anatomopathologiste va répondre. PTA.

PTIS. Lorsqu'on a une tumeur plan. Non infiltrante.

PT1. Lorsqu'il y a infiltration du chorion. PT2.

Lorsqu'il y a atteinte du muscle. Couche superficielle. Couche profonde.

PT3. Extension de l'atmosphère péri-vésicale. Microscopiquement.

Et macroscopiquement. PT4. Extension aux organes de voisinage.

Toujours sur le stade TNM. Des tumeurs vésicales. Mais sur un schéma.

Avec un neurotélium qui est ici. Dessiné. Le neurotélium, le chorion.

Les muscles avec les deux couches. Le tissu adipopéri-vésical. Et les organes de voisinage.

Lorsqu'on a une tumeur qui n'infiltré pas le chorion. Si c'est une lésion plane. C'est un carcinome in situ.

On va stader PTIS. Si c'est une lésion papillaire. Qui n'infiltré pas le chorion.

PTA. Si maintenant la lésion infiltre le chorion. C'est une tumeur infiltrante.

Pour les anatomes pathologiques. Mais qui n'atteint pas le muscle. C'est un PT1.

C'est trois lésions. Mais notamment. Papillaire n'infiltrant pas le chorion.

Et infiltrant juste le chorion. La biopsie. Et le traitement curatif.

Le malade sera. Suivi après. Pour voir s'il y a une récurrence ou une progression.

Maintenant si la tumeur atteint le muscle. Là, la conduite à tenir est différente. C'est la cystectomie.

C'est la limite importante. À connaître pour les urologues. C'est à ce moment là que le geste.

Va différer. On part vers un geste plus agressif. Lorsque la tumeur infiltre le tissu adipeux.

Périvésical. On est en PT3. Organes de voisinage.

On est en PT4. Les données épidémiologiques ont permis. De trouver une étroite corrélation.

Entre le stade TNM. Et la survie du patient. Elle est de l'ordre de 71% à 10 ans.

Pour les stades PTIS, PTA et PT1. Donc superficielle. Elle est à 48% de survie à 10 ans.

Lorsqu'on est en PT2. Donc infiltration du muscle. Elle chute à 23% à 10 ans.

Lorsqu'on est en PT3. Ou PT4. Passons maintenant aux tumeurs épithéliales.

Mais non neurothéliales. Elles sont dominées par deux tumeurs. Le carcinome épidermoïde.

Dans 3 à 7%. Dans ce cas. Il faut chercher.

Une bilharziose qui aurait pu causer. Le carcinome épidermoïde. La deuxième tumeur.

C'est l'adénocarcinome dans 2% des cas. Souvent. Sur les zones d'extrophie vésicale.

De métaplasie glandulaire. Ou sur vestiges embryonnaires. Attention.

Le troisième tumeur. Pensez à éliminer une extension. D'un cancer de voisinage.

Avant de parler d'une tumeur primitive. Un carcinome épidermoïde. Par exemple du colutérin.

Avant de parler d'un carcinome épidermoïde de la vessie. Ou d'un adénocarcinome de la prostate. Du rectum.

Ou du colon. Avant de parler d'un adénocarcinome primitif. Autre tumeur possible.

Des carcinomes indifférenciés. Ou des tumeurs neuroendocrines. Le carcinome épidermoïde.

Par exemple avec des phénomènes irritatifs chroniques de la vessie. Notamment par des oeufs de bilharzie. Ou une litiase vésicale.

L'aspect est classique. Avec présence de boyaux. De cellules cohésives.

Avec des ponts d'union. Et des globes cornés. Il faut s'acharner à trouver des oeufs de bilharzie.

A proximité. Pour expliquer le développement du carcinome épidermoïde. Mais toujours.

Attention à une atteinte secondaire. Notamment du colutérin. Qui pourrait être prise à tort.

Pour un carcinome primitif de la vessie. Sur le version très bien différenciée. Du carcinome épidermoïde.

On peut avoir le carcinome verruqueux. C'est une tumeur qui est assez rare. Au niveau de la vessie.

L'aspect ne diffère pas. Des autres carcinomes verruqueux. Des autres localisations.

Aspect d'un adénocarcinome. Au niveau de la vessie. Mais encore une fois.

Pensez toujours à éliminer une cause secondaire. Notamment une extension de voisinage. Avant d'opter pour un adénocarcinome de la vessie.

Qui est une tumeur assez rare. Concernant les tumeurs non épithéliales. Elles sont beaucoup plus rares.

On peut avoir des tumeurs mesenchymateuses. Notamment le Rhabdomyosarcom. Chez l'enfant.

Le Liomyosarcom. Des tumeurs mélaniques. Et même des tumeurs hématopoïétiques et lymphoïdes sont décrites.

Ce sont des tumeurs, encore une fois, exceptionnellement retrouvées. Attention aux métastases et extensions d'une tumeur de voisinage au niveau de la vessie. Qui peuvent être prises pour une tumeur primitive de la vessie.

Notamment le Colutéra. Extension de voisinage. Pas même des adénocarcinomes du poumon.

Avec métastases au niveau de la vessie. Passons rapidement aux tumeurs excatrices piélocalicielles et urétérales. Elles dérivent de l'Urotélium.

Qui recouvre les voies excatrices supérieures de la région piélocalicielle et uréterale. Elles sont rares. Elles représentent 7% de toutes les tumeurs localisées au rein.

Et 5% de l'ensemble des tumeurs urotéliales. Concernant les circonstances de découverte. Ça peut être une hématurie.

Ou des douleurs. Mais ça peut être aussi dans le bilan d'une tumeur de vessie. En effet, 2 à 4% des patients ayant une tumeur de vessie.

Développent une tumeur des voies excatrices supérieures. Soit en même temps de façon synchrone. Ou métachrone.

Ce qui justifie une surveillance du haut appareil urinaire dans le suivi des tumeurs de vessie traitées. Sur le plan microscopique. Elles ressemblent aux tumeurs de la vessie.

Avec dans 95% des cas. Des tumeurs de type urotéliale. La particularité.

C'est qu'elles répondent à une pathologie d'appareil. Ou de l'urotélium. Dans 7 à 10% des cas.

Elles vont atteindre volontiers l'appareil excréto-urinaire. Avec des lésions multifocales. Bilatérales.

Et des récives fréquentes. Elles peuvent s'étendre. A l'urtere distale.

Voir la vessie. En conclusion. Les tumeurs de vessie sont des tumeurs fréquentes.

Elles peuvent être de type papillaire. Ou plane. Le diagnostic anatomopathologique est capital.

Il permet de diagnostiquer ses lésions. D'apprécier le risque d'évolutivité. Et de progression.

Et de préciser le degré d'infiltration. De la tumeur. Est-ce qu'elle est infiltrante ? Et si elle est infiltrante, est-ce qu'elle infiltre le chorion ? Ou le muscle ? C'est un acte capital sur le traitement.

Une simple exérèse biopsique lorsqu'elle infiltre le chorion. Est suffisante. Une cystectomie est

obligatoire lorsqu'elle a une infiltration du muscle.

De ce fait. Le matériel doit être non altéré. Pour permettre de bien apprécier le plan musculaire.

Et de toutes les manières. La confrontation anatomoclinique est capitale.